ICS 11.020
CCS C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.3—2021
代替 GB/T 21709.3—2008

针灸技术操作规范　第3部分:耳针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 3:Ear acupuncture

2021-11-26 发布　　2021-11-26 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 21709《针灸技术操作规范》的第3部分。GB/T 21709已经发布了以下部分:

——第1部分:艾灸;
——第2部分:头针;
——第3部分:耳针;
——第4部分:三棱针;
——第5部分:拔罐;
——第6部分:穴位注射;
——第7部分:皮肤针;
——第8部分:皮内针;
——第9部分:穴位贴敷;
——第10部分:穴位埋线;
——第11部分:电针;
——第12部分:火针;
——第13部分:芒针;
——第14部分:鍉针;
——第15部分:眼针;
——第16部分:腹针;
——第17部分:鼻针;
——第18部分:口唇针;
——第19部分:腕踝针;
——第20部分:毫针基本刺法;
——第21部分:毫针基本手法;
——第22部分:刮痧。

本文件代替GB/T 21709.3—2008《针灸技术操作规范　第3部分:耳针》,与GB/T 21709.3—2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

——增加了“耳穴电针法”“耳穴按摩法”两种耳针操作方法的术语和定义(见3.6和3.7),以及施术步骤要求(见4.2.5和4.2.6);
——更改了“耳针”“耳穴压丸法”定义(见3.1和3.3,2008年版的2.1和2.3);
——在“针具及压丸(器具)选择”中,增加了器具要求(见4.1.1);
——更改了“耳穴选择”要求(见4.1.2,2008年版的3.1.2);
——更改了针具和医者消毒要求(见4.1.5.1和4.1.5.3,2008年版的3.1.5.1和3.1.5.3);
——更改了“耳穴刺血法”施术步骤要求(见4.2.4,2008年版的3.2.4);
——增加了不能配合施术的患者的禁忌要求(见6.3);
——更改了局部的耳穴禁忌要求(见6.1,2008年版的5.1);
——更改了附录A的性质(见附录A);
——增加了规范性附录B。

本文件由国家中医药管理局提出。

本文件由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本文件起草单位:天津中医药大学、河北中医学院、北京中医药大学、佛山市中医院。

本文件主要起草人:李桂兰、郭义、刘继洪、陈泽林、贾春生、刘清国、程凯、赵百孝、李庆雯、努娜、杜凯、张玄、王娟、李迎斌、刘妮波、李燕、宋海阔、金宗英、李桂华、步怀恩、韩丽、李虹、赵慧玉。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2008 年首次发布为 GB/T 21709.3—2008;

——本次为第一次修订。

引　言

针灸技术操作规范是对各种针灸疗法操作程序、步骤、方法等方面所做的统一技术操作规定。在针灸技术操作规范方面，我国已经制定了系列标准 GB/T 21709。GB/T 21709《针灸技术操作规范》旨在确立普遍适用于针灸临床、教育、科研等方面关于针灸技术操作的工作准则，拟由 22 部分组成。

——第 1 部分：艾灸。目的主要在于规范艾灸疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应艾灸实践发展新变化与新需求。

——第 2 部分：头针。目的主要在于规范头针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应头针实践发展新变化与新需求。

——第 3 部分：耳针。目的主要在于规范耳针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应耳针实践发展新变化与新需求。

——第 4 部分：三棱针。目的主要在于规范三棱针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应三棱针实践发展新变化与新需求。

——第 5 部分：拔罐。目的主要在于规范拔罐疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应拔罐实践发展新变化与新需求。

——第 6 部分：穴位注射。目的主要在于规范穴位注射疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位注射实践发展新变化与新需求。

——第 7 部分：皮肤针。目的主要在于规范皮肤针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应皮肤针实践发展新变化与新需求。

——第 8 部分：皮内针。目的主要在于规范皮内针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应皮内针实践发展新变化与新需求。

——第 9 部分：穴位贴敷。目的主要在于规范穴位贴敷疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位贴敷实践发展新变化与新需求。

——第 10 部分：穴位埋线。目的主要在于规范穴位埋线疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位埋线实践发展新变化与新需求。

——第 11 部分：电针。目的主要在于规范电针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应电针实践发展新变化与新需求。

——第 12 部分：火针。目的主要在于规范火针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应火针实践发展新变化与新需求。

——第 13 部分：芒针。目的主要在于规范芒针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应芒针实践发展新变化与新需求。

——第 14 部分：鍉针。目的主要在于规范鍉针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应鍉针实践发展新变化与新需求。

——第 15 部分：眼针。目的主要在于规范眼针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应眼针实践发展新变化与新需求。

——第 16 部分：腹针。目的主要在于规范腹针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应腹针实践发展新变化与新需求。

——第 17 部分：鼻针。目的主要在于规范鼻针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应鼻针实践发展新变化与新需求。

——第 18 部分：口唇针。目的主要在于规范口唇针疗法的相关概念、操作步骤与要求、疗程与适应

症、注意事项、禁忌等，以适应口唇针实践发展新变化与新需求。

——第 19 部分：腕踝针。目的主要在于规范腕踝针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应腕踝针实践发展新变化与新需求。

——第 20 部分：毫针基本刺法。目的主要在于规范毫针基本刺法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应毫针基本刺法实践发展新变化与新需求。

——第 21 部分：毫针基本手法。目的主要在于规范毫针针刺手法的相关概念、施术方法、注意事项、禁忌等，以适应毫针基本手法实践发展新变化与新需求。

——第 22 部分：刮痧。目的主要在于规范刮痧疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应刮痧实践发展新变化与新需求。

针灸技术操作规范　第3部分:耳针

1　范围

本文件规定了耳针的操作步骤与要求、注意事项与禁忌。

本文件适用于耳针技术操作。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

耳针　ear acupuncture

采用毫针、压丸、埋针、刺血、电针、按摩等一系列操作刺激耳穴以防治疾病的一类方法。

3.2

耳穴毫针法　ear acupuncture therapy

使用毫针刺入耳穴以防治疾病的一种方法。

3.3

耳穴压丸法　ear plaster therapy

使用特定丸状物贴压耳穴以防治疾病的一种方法。

3.4

耳穴埋针法　ear needle-embedding therapy

使用揿针埋入耳穴以防治疾病的一种方法。

3.5

耳穴刺血法　ear bloodletting pricking therapy

使用一定针具点刺耳穴出血以防治疾病的一种方法。

3.6

耳穴电针法　ear electro-acupuncture therapy

使用电针刺激耳穴以防治疾病的一种方法。

3.7

耳穴按摩法　ear massage therapy

使用手或耳穴按摩棒刺激耳穴以防治疾病的一种方法。

4 操作步骤与要求

4.1 施术前准备

4.1.1 针具及压丸(器具)选择

针具针身应光滑、无锈蚀,针尖应锐利、无倒钩,压丸应圆润、大小适宜、不易碎、无毒。按摩棒应不易折断、无毒,施术端应圆钝、光滑、大小适宜。

4.1.2 耳穴选择

根据病情,并结合中医理论、现代医学及临床经验选择耳穴。

4.1.3 体位选择

选择患者舒适、医者便于操作的体位。

4.1.4 环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

4.1.5 消毒

4.1.5.1 针具消毒:应选择一次性无菌针具。

4.1.5.2 部位消毒:应用75%乙醇或碘伏在施术部位擦拭。

4.1.5.3 医者消毒:医者双手先按七步洗手法洗净,再用75%乙醇擦拭。

4.2 施术方法

4.2.1 耳穴毫针法

医者一手固定耳郭,另一手拇、食、中指持针刺入耳穴。针刺方向视耳穴所在部位灵活掌握,针刺深度宜0.1 cm～0.3 cm,以不穿透对侧皮肤为度。针刺手法与留针时间应视患者的病情、体质及耐受度综合考虑。宜留针15 min～30 min,留针期间应间断行针1次～2次。出针时一手固定耳郭,另一手将针拔出,应用无菌干棉球或棉签按压针孔。

4.2.2 耳穴压丸法

医者一手固定耳郭,另一手用镊子夹取耳穴压丸贴片贴压耳穴并适度按揉,根据病情嘱患者定时按压。宜留置2 d～4 d。耳穴压丸贴片应按照附录A制备。

4.2.3 耳穴埋针法

医者一手固定耳郭,另一手用镊子或止血钳夹住揿针针柄刺入耳穴,用医用胶布固定并适度按压,根据病情嘱患者定时按压,宜留置1 d～3 d后取出揿针,应消毒埋针部位。

4.2.4 耳穴刺血法

医者佩戴一次性乳胶或薄膜手套,刺血前宜按摩耳郭使所刺部位充血,医者一手固定耳郭,另一手持针点刺耳穴,挤压使之适量出血。施术后以无菌干棉球或棉签压迫止血并消毒刺络部位。

4.2.5 耳穴电针法

用酒精棉球消毒耳穴部位，医者一手固定耳郭，另一手拇、食、中指持针刺入耳穴。针刺方向视耳穴所在部位灵活掌握，针刺深度宜 0.1 cm～0.3 cm，以不穿透对侧皮肤为度。并根据病情选择好所需的波形和频率，将电针仪的一对输出导线的正、负极分别连接在两根毫针柄上（一对导线的正、负二极宜接在同侧耳郭，二枚以上者宜远距离相接配对），再拨动电位器开关，逐渐调高输出电流至所需的刺激量。电流刺激量应根据病情而定，宜留针 15 min～30 min，出针时一手固定耳郭，另一手将针拔出，用无菌干棉球或棉签按压针孔。

4.2.6 耳穴按摩法

医者用手或耳穴按摩棒对准耳穴部位，施以一定力度及手法，时间宜 5 min～10 min。应按照附录 B 具体操作。

5 注意事项

5.1 施术部位应防止感染。

5.2 紧张、疲劳、虚弱患者宜卧位针刺以防晕针。

5.3 湿热天气、耳穴压丸、耳穴埋针留置时间不宜过长，耳穴压丸宜 2 d～3 d，耳穴埋针宜 1 d～2 d。

5.4 耳穴压丸、耳穴埋针留置期间应防止胶布脱落或污染，对普通胶布过敏者宜改用脱敏胶布。

5.5 耳穴刺血施术时，医者应戴医用手套避免接触患者血液。

5.6 妊娠期间慎用耳针。

6 禁忌

6.1 脓肿、溃破、感染、冻疮、瘢痕局部的耳穴禁用耳针。

6.2 凝血机制障碍患者不应使用耳穴刺血法。

6.3 不能配合施术的患者，禁用耳针、电针及埋针等操作。

附　录　A
（规范性）
耳穴压丸贴片的制备

将医用胶布剪成约 0.6 cm×0.6 cm 大小，上置压丸制成耳穴压丸贴片，压丸直径约 0.2 cm，应清洗消毒，宜选用植物种子，如王不留行子、白芥子、急性子、莱菔子、油菜籽等；或选用聚苯乙烯珠、磁珠等。目前，临床上广泛使用的是王不留行子和磁珠。

附　录　B
（规范性）
耳穴按摩手法

耳穴按摩手法主要包括按揉法、点按法、按掐法、提捏法、擦法、摩法。依据耳穴所在部位选择适合的按摩操作手法。

B.1　按揉法

是按法与揉法的复合动作，用按摩棒或手指罗纹面置于耳穴部位，前臂和手指施力，进行节律性按压揉动。

B.2　点按法

是以按摩棒或食、中指指端的罗纹面着力，垂直向下按压。

B.3　按掐法

是指术者手握空拳，拇指伸直，指腹紧贴在食指中节桡侧缘，拇指指甲垂直于耳穴，逐渐用力，达到“以指代针”之效。

B.4　提捏法

是指术者肩、肘关节放松，腕关节略背伸，用拇指与食、中两指相对用力挤压并向外提拉患者耳郭。

B.5　擦法

是用按摩棒或手指指腹贴附于耳郭表面，做较快速的往返直线运动，使之摩擦生热。

B.6　摩法

是以单指（拇指、食指、中指）或食指、中指、无名指与小指并拢，指掌自然伸直，腕关节略屈，以指面附着于耳郭部位，做环形而有节律的抚摩。